

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine de Constantine
Département de Médecine

CAT

DEVANT UN ICTÈRE FÉBRILE

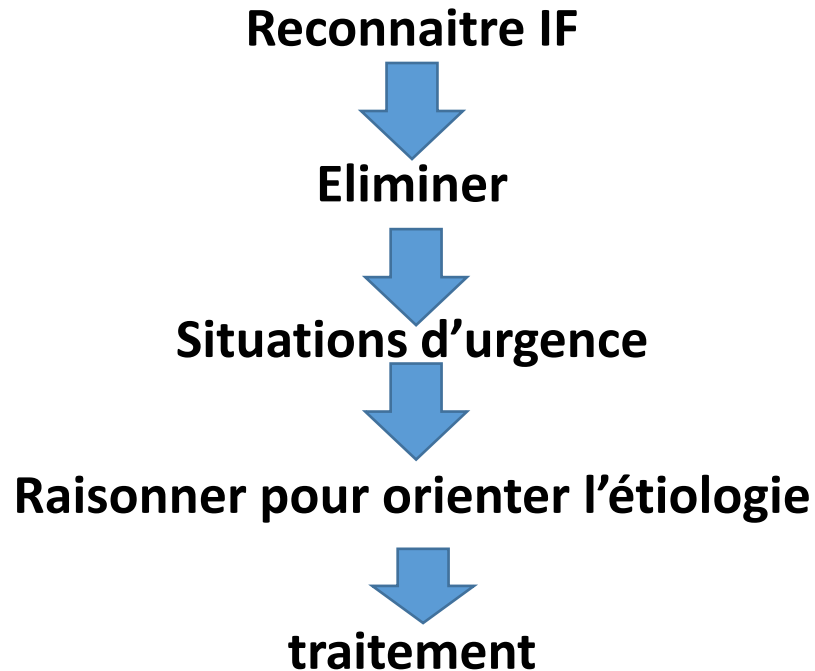
Module de Maladies Infectieuses
Quatrième Année de Médecine
Année Universitaire : 2024/2025

Dr. BERBADJ.M
Dr. CHACHOU.B

OBJECTIFS

- Reconnaître les **situations urgentes** et planifier leur **prise en charge**
- Etablir une **démarche pour le diagnostic étiologique**

CAT DEVANT UN ICTÈRE FÉBRILE



CAT DEVANT UN ICTERE FÉBRILE

PLAN:

I/INTRODUCTION: I.1. DÉFINITION

I.2. INTÉRÊT DE LA QUESTION

II/PHYSIOLOGIE

III/PHYSIOPATHOLOGIE

IV/DIAGNOSTIC : IV.1. DIAGNOSTIC POSITIF

IV.2. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

IV.3. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

✓ SITUATION URGENTES

✓ AUTRES SITUATIONS

V/CONCLUSION

I. INTRODUCTION

I.1. DÉFINITION

- **Ictère** = Coloration jaune de la peau et des conjonctives, consécutive à une accumulation dans le plasma d'un pigment physiologique qui est la bilirubine.
- Taux plasmatiques de bilirubine > 20 micromoles/l
 - sub-ictère : bilirubine > 20 micromoles/l
 - ictère : bilirubine > 50 micromoles/l

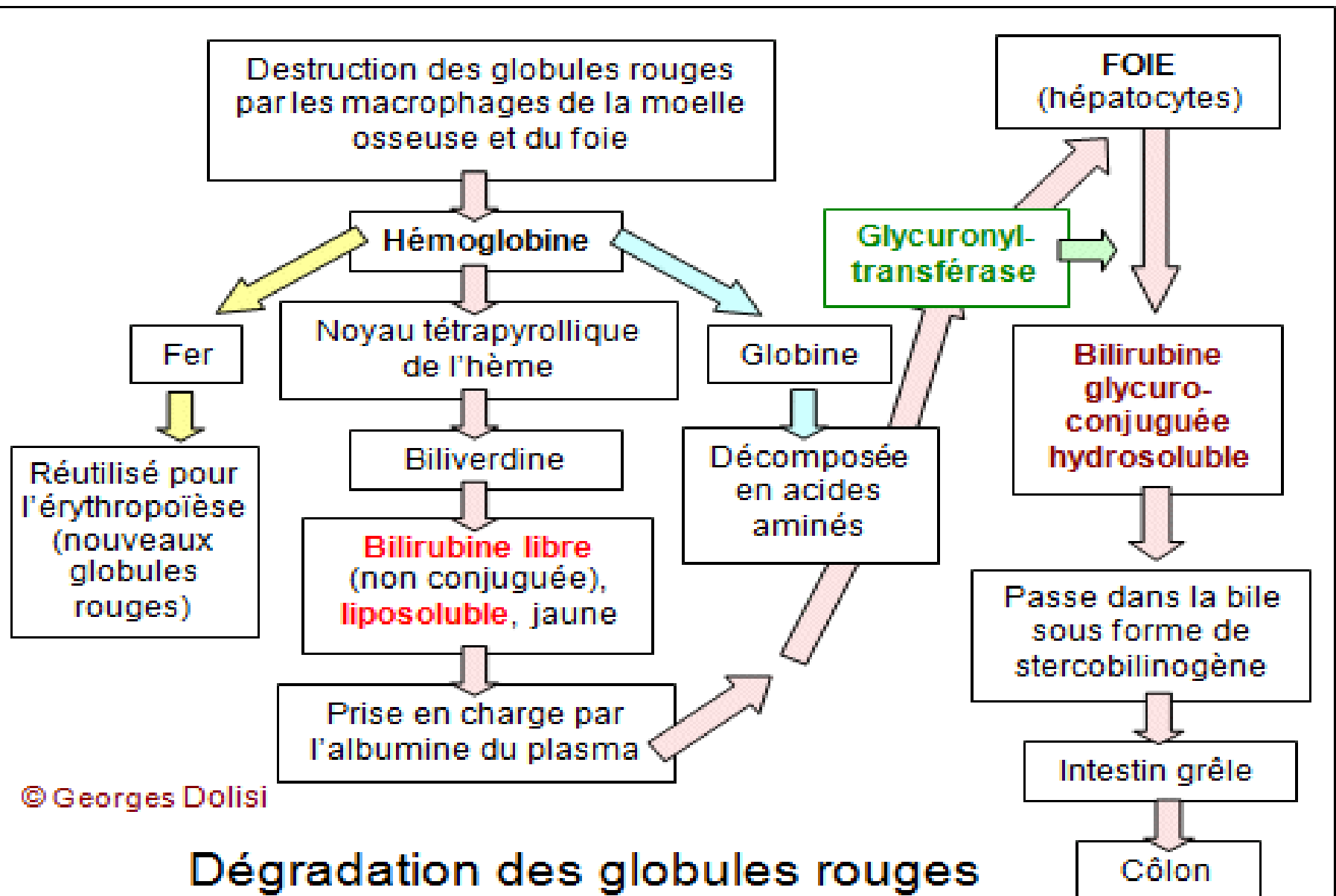
ICTÈRE FÉBRILE: ICTÈRE + FIÈVRE



I.2. INTERET DE LA QUESTION

- Situation **clinique fréquente**
- Diagnostic **clinique facile**
- Étiologies multiples **notamment infectieuses**
- Séjours en zone d'endemie palustre: **paludisme**
- Dans certains cas: **URGENCE** thérapeutique
- Traitement en **fonction de l'étiologie**

II. PHYSIOLOGIE



II. PHYSIOLOGIE

GLOBULES ROUGES → 120 J



HEMOLYSE



hémoglobine



hème + globine



bilirubine L



acides aminés



FOIE



RECYCLAGE



BILIRUBINE CONJ



BILE → INTESTIN → STERCOBILINE (SELLES)

II. PHYSIOPATHOLOGIE

Il existe 3 types d'ictère:

**Ictère à bilirubine libre
ou non conjuguée:
plus de 70% bilirubine totale**

- Hyperproduction de bilirubine par **hémolyse**
- Défaut de glucuroconjugaison: anomalie **génétique** (maladie de Gilbert, Crigler- Najar) ou **médicamenteuse**.

**Ictère à bilirubine
conjuguée :
plus de 80% bilirubine totale**

- Cholestase intra-hépatique: atteinte des **hépatocytes** ou des **VB intra-hépatiques**: souvent incomplète
- Cholestase extra-hépatique: obstruction des **VB extra-hépatiques**

Ictère mixte:

**50% bilirubine L et
50% de bilirubine C**

- Déficit constitutionnel intra-hépatique de la synthèse biliaire

La fièvre peut se voir au cours d'un ictère qui n'est pas d'origine infectieuse: **hémolyse non infectieuse, cancer, maladie auto-immune**

Au cours des maladies infectieuses :

V/DIAGNOSTIC

DÉMARCHE DIAGNOSTIC



1 - Identifier les situations d'urgence



2 - Reconnaître l'ictère, son type



3 - Diagnostic étiologique avec 3 volets

- interrogatoire,
- examen clinique
- examens para cliniques

V.1.DIAGNOSTIC POSITIF: Reconnaître l'ictère

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE :

- L'ictère cutanéomuqueux est souvent évident avec coloration jaune de la peau, de la cavité buccale et des conjonctives.
- Le prurit, peut s'accompagner de lésions de grattage.
- Les urines sont foncées et les selles sont décolorées.
- Parfois la constatation juste d'un sub-ictère conjonctival



CONFIRMER LE CARACTERE FEBRILE DE L'ICTERE :

La fièvre se définit comme une augmentation de la T° centrale dépassant 38°C le matin, 38,3°C le soir, alors que le sujet est au repos depuis plus d'un quart d'heure, et à jeun depuis plus de 02 h.

V.1.DIAGNOSTIC POSITIF: Reconnaître l'ictère

Confirmation biochimique :

- Taux plasmatiques de **bilirubine** > **20 micromoles/l**
 - **sub-ictère** : bilirubine > 20 micromoles/l
 - **ictère** : bilirubine > 50 micromoles/l



Reconnaître le type de l'ictère:

DONNÉES CLINIQUES + DONNÉES BIOLOGIQUES

1. Ictères à bilirubine libre:

- urines claires
- coloration des selles normales
- pas de prurit
- tests hépatiques nx
- hyperbilirubinémie libre**

2. Ictères à bilirubine conjuguée

- urines foncées
- selles décolorées
- prurit parfois présent
- anomalies des tests hépatiques
- hyperbilirubinémies conjuguée**



Identifier les situations d'urgence :

-signes de défaillance

hémodynamique:

hypotension, pouls accéléré,
oligo-anurie.

-Signes d'insuffisance

hépatocellulaire:

Syndrome hémorragique, angiomes
stellaires, atrophie hépatique.

-signes

d'encéphalopathies

hépatique:

troubles du comportement,
tremblement.

-signes d'hémolyse aigue:

pâleur cutanéomuqueuse,
tachycardie, SPM.



V.1.DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL



Pâleur jaune de certaine anémie



Hypercaroténémie

V.3.DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

a/- Interrogatoire : recherchez :

- Les antécédents familiaux d'hémoglobinopathies
- Notion de lithiase vésiculaire
- Intervention sur les voies biliaires
- Avortement, accouchement
- Colique hépatique (douleur de l'Hypochondre Droit après un repas riche en graisse)
- Notion de voyage (paludisme et fièvre jaune)
- Profession (égoutier, mineur) et notion de loisir (pêche, baignade...etc.)
- Prise de médicaments (on dénombre 3600 médicaments pouvant donner un ictère comme le Paracétamol, les AINS...etc.

*- **Caractères de l'ictère**: prodromes, mode de début, circonstances d'apparition, évolution, signes associés (digestifs, pancréatiques), AEG...

b/- Examen clinique :

- **Inspection :**

intensité de l'ictère, circulation veineuse collatérale, angiomes stellaires, lésions de grattage, tatouage, distension abdominale, pâleur cutanéomuqueuse.

- **Percussion et palpation :**

- Etat du foie :
- Une splénomégalie: hémolyse ou hypertension portale
- Une ascite oriente vers une cirrhose.
- État de la vésicule biliaire la palpation d'une grosse vésicule signifie un obstacle à l'écoulement de la bile au niveau du cholédoque (cancer de la tête du pancréas ++).

c/- Examens biologiques :

- **FNS :**
 - Anémie (hémolyse);
 - Hyperleucocytose (lithiase de la VBP);
 - Hyper éosinophilie (hépatite médicamenteuse);
 - Leucopénie (hépatite virale).
- **Transaminases:**(ALAT, ASAT) très élevées dans les hépatites virales aiguës.
- **Phosphatases alcalines, gamma glutamyl transférase (GGT)** dans les ictères choléstatiques.

d/-Autres examens biologique:

Ils doivent être orientés par l'interrogatoire, l'examen physique et la biologie initiale:

- Fer sérique et taux de réticulocytes : dans les hémolyses.
- Sérologies virales : Hépatites (A, B, C, D et E) , MNI, CMV, VIH
- Sérologies bactériennes: leptospirose, rickettsiose, syphilis, brucellose, fièvre typhoïde
- Sérologie parasitaire : amibienne, Kyste Hydatique.
- Goutte épaisse et FSP.
- Electrophorèse des protides :
 - *- albumine dans les insuffisances hépatocellulaire,
 - *- gamma globulines dans les hépatopathies chroniques.
- Marqueurs d'auto-immunité
- Dosage d' α -foeto-protéine sérique.
- Hémocultures

e/- Examens morphologique :

Échographie abdominale +++ permet l'étude :

- Des voies biliaires intra et extra-hépatiques : dilatées ou non
- Du foie : présence d'images nodulaires,.....
- De la vésicule biliaire
- Du pancréas
- Présence ou non d'une ascite, des adénopathies profondes, splénomégalie.

Le scanner abdominale:

Pour une meilleure visualisation des VB

Rechercher d'autres anomalies hépatiques ou extra-hépatiques

IRM abdominale voire CHOLANGIO-IRM :

Surtout en cas d'une suspicion d'un obstacle des VB non visualisé à l'échographie

AU TERME DE NOTRE EXAMEN CLINIQUE:



Les situations urgentes :

1- angiocholite	2-sepsis grave + ira	3- hépatite fulminante → ice hépato cellulaire	4-neuropaludisme
- ATCD lithiasse ou cholécystectomie - dlr hpc dt, fièvre, frissons+++, ictère - écho abdominale - HMC - ATB +++	- BGN, anaérobies (clostridium perf), leptospirose - HMC, PE - ATB +++	- encéphalopathie - hémorragies - cytolyse +++ - TP ↓ fact v↓	- retour d'un pays tropical - frottis sg, GE

Différentes Etiologies

Ictères fébriles à bilirubine libre (1)

Signes d'hémolyse:

- Anémie, réticulocytes et LDH élevés
- Haptoglobine effondrée, hémoglobinurie

Etiologies infectieuses d'hémolyse :

- Paludisme
- Infection à *Clostridium perfringens* (avortements, intervention gynéco)
- Anémie hémolytique auto-immune au cours d'infections:
 - ** - bactériennes (Mycoplasme+++, *Chlamydia*) ou
 - ** - virales: EBV, CMV, VHA, VHB, VIH, Arboviroses

Différentes Etiologies

Ictères fébriles à bilirubine libre (2)

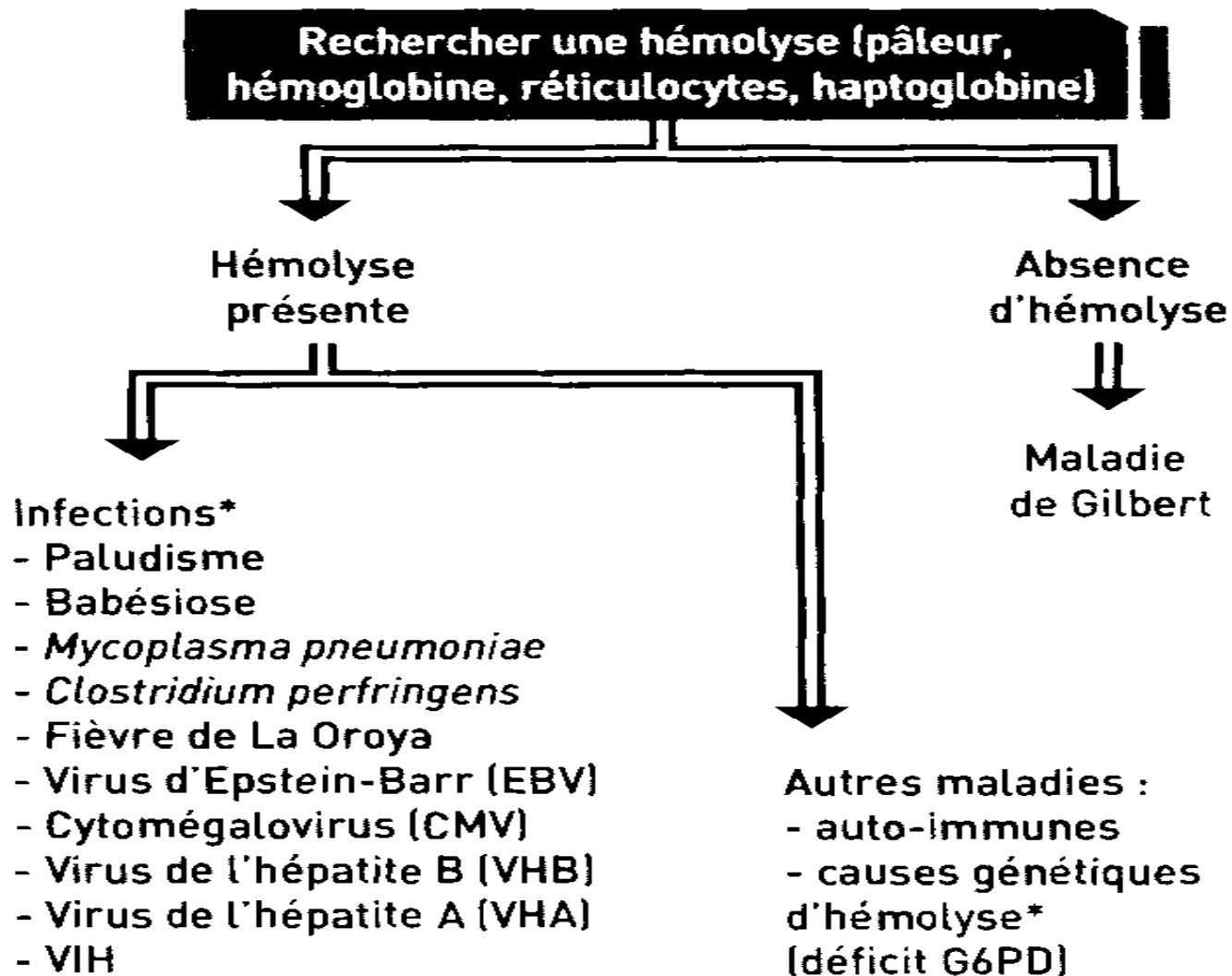
Etiologies non infectieuses d'hémolyse :

autres causes d'hémolyse qui peuvent s'accompagner de fièvre sont:

- Hémoglobinopathie (drépanocytose, thalassémie,...)
- Erythro-enzymopathie (déficit en G6PD)

NB: les poussées d'hémolyse peuvent être déclenchées par une infection intercurrente

F15-1 : CAT DEVANT UN ICTÈRE FÉBRILE À BILIRUBINE LIBRE



Différentes Etiologies

Ictère fébrile à bilirubine conjuguée à VB fines (1)

Etiologies infectieuses :

1. Anomalies focales du parenchyme hépatique :

- *Kystes hépatiques* :
- *Abcès hépatiques* : pyogènes, amibes, champignons

2. Foie homogène

- **Hépatites virales ++++**:
 - *- hépatites virales A, B, C, D, E
 - *-autres virus à tropisme hépatique : herpès virus, CMV, EBV
- **Leptospirose ictéro-hémorragique**

3. Hépatites granulomateuses bactériennes :

- Mycobactéries
- Fièvre Q, brucellose, syphilis

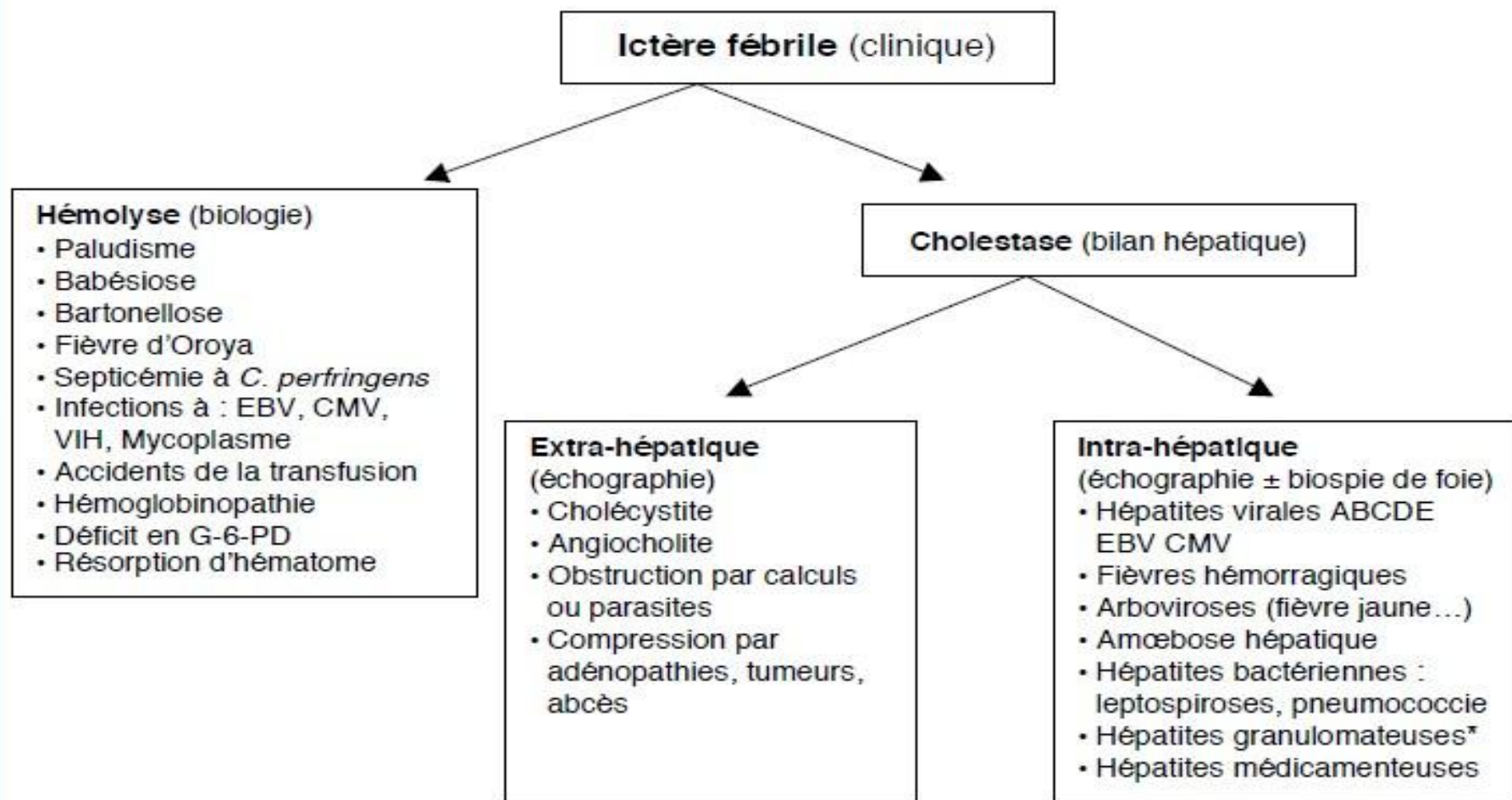
Différentes Etiologies

Ictère fébrile à bilirubine conjuguée à VB fines (2)

Etiologies non infectieuses :

- Cancer du foie (cancer primitif ou secondaire),
- Lymphome malin hodgkinien ou non hodgkinien
- Hépatites toxiques : médicaments, alcool
- Insuffisance cardiaque droite
- Causes plus rares: cirrhose biliaire primitive, cholangite sclérosante, cholestase gravidique

Figure 1. Conduite à tenir devant un ictère fébrile



* Principales causes d'hépatites granulomateuses tropicales :

- tuberculose, mycobactéries atypiques, lèpre, syphilis, fièvre Q, brucellose ;
- infections à CMV et EBV ;
- bilharziose, ascaridiose, anguillulose, toxocarose, filariose, leishmaniose viscérale ;
- histoplasmosse, coccidioïdomycose, aspergillose, candidose, actinomycose ;
- médicaments (sulfamides).

V. CONCLUSION

- L'ictère fébrile constitue **une urgence diagnostique** et certaines étiologies nécessitent des mesures thérapeutiques urgentes, elles doivent être toujours évoquées en premier lieu.
- Seule une analyse attentive des données anamnestiques, cliniques et paracliniques permet d'aboutir à un diagnostic étiologique et par conséquent la mise en route d'un traitement adéquat.